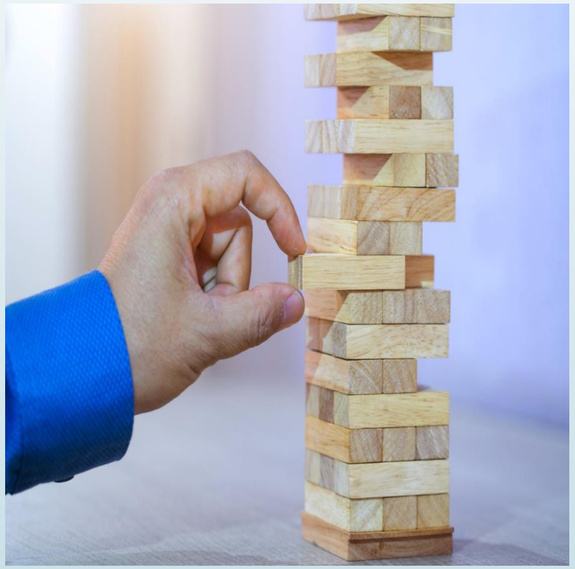
# MODÈLE LOGIQUE




Présentée par le groupe 1 :

- **Bouzid M BAREK**
- **Diaby MASSIRE**
- **Grâce MEYOU**
- **Kolie NYANKOYE**
- **Maxime GRONDIN-LECLERC**

À

**Madame Sivime El Tayeb El Rafei**


## TEN-7006 : DESIGN DES SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

**HIVER 2026**

# Modèle logique_Formation continue en hygiène et salubrité au Centre d'hébergement des soins de longue durée (CHSLD)

## CONTEXTE / BESOIN

Le service d'hygiène et salubrité (H&S) fait face à un déficit de performance critique caractérisé par l'absence d'un programme de formation continue structuré. Cette lacune, combinée à un taux de roulement élevé du personnel (30-40%), une maîtrise limitée de technologie et à la perte d'expertise technique. Ceci revient au départ à la retraite des employés expérimentés, compromet la qualité des services et augmente les risques d'infections nosocomiales pour les résidents vulnérables.

**OBJECTIF GÉNÉRAL**

Assurer la protection et le bien-être des résidents en optimisant le service d'hygiène et salubrité au sein des établissements du Groupe Roy Santé, en réduisant de 10% le risque de transmission des infections dans les 12 à 18 mois suivant l'implantation de la solution.

**GROUPES CIBLES :**

Principals : Personnel H&S (nouveaux, temps plein et temps partiel)
Secondaires : Gestionnaires (cheffe, chef d'installation)

## INTRANTS

**Ressources humaines**
- Le personnel du département HS
- Techno pédagogue
- Formateur interne
- Expert en:
  - Microbiologie
  - Contamination
  - Contrôle de qualité

**Ressources matérielles**
- Plateforme de gestion de la formation (Uxpertise)
- Tablettes numériques, téléphone intelligent ou ordinateur
- Équipement microfibres
- Équipement de nettoyage

**Ressources organisationnelles**
- Normes MSSS, fiches SIMDUT
- Budget formation (0,5 % masse salariale)
- Ressources audio-visuels de l'organisme

**Ressources Financières**
- Roy santé

## ACTIVITÉS

**Formation**
- Modules courts sur tablette (Micro-learning)
- Capsules vidéo démonstratives

**Soutien**
- Accompagnement ciblé selon les profils
- Tableaux réguliers (capsules, affiches, notifications)
- Mentorat par employés expérimentés

**Évaluations et suivi**
- Quiz et test de connaissance
- Observation directe avec rétroaction immédiate
- Audit
- Suivi des résultats sur le LMS
- Ajustement continue du programme
- Auto-évaluation

## EXTRANTS

**Extrants liés à la formation**
Nombre de modules créés
Nombre de participants formés
Modules e-learning produits

**Extrants numériques ou technologiques**
- Documents publiés (guides, FAQ, capsules vidéos)
- Rétroactions immédiates
- Campagnes diffusées
- Plateforme en ligne développée
- Base de données mise à jour

**Extrants liés à des services**
- Consultations réalisées
- Inspections effectuées
- Rapports ou analyses produits

## RÉSULTATS

**Court terme (1 à 6 mois)**
- Meilleure compréhension du rôle du personnel H&S
- Meilleure compréhension des risques
- Amélioration immédiate de la qualité de nettoyage
- Uniformité des pratiques de base

**Moyen terme (6 mois à 12 mois)**
- Conformité audits 90 % (UV/ATP)
- Aucun cas de contamination croisée
- Réduction erreurs de dilution/séquence

**Long terme (12 à 18 mois)**
- -10 % risque de transmission d'infections
- Stabilité accrue des équipes (roulement)
- Culture de qualité durable

## INDICATEURS DE MESURE

**Qualitatifs**
- Sondage d'appréciation
- Observation directe

**Quantitatifs**
- Budget formation utilisé (100%)
- Taux de participation à la formation (100%)
- Nombre d'employés formés
- Taux de rétention des employés (80%)
- Score moyen aux quiz post-formation (80%)
- Taux de conformité aux audits H&S (90%)
- Réduction du taux d'infections nosocomiales (95%)

**Outils**
- Manipulation des machines "High touch"
- Données statistiques

## HYPOTHÈSES

1-Une formation continue structurée améliore les compétences du personnel.
2-Le renforcement des compétences technologiques favorise l'application conforme des protocoles d'hygiène.
3-L'amélioration des compétences du personnel accroît la qualité et la constance des services d'hygiène.
4-Un personnel formé et soutenu contribue à réduire le taux de roulement.
5-Un programme de formation structuré limite la perte d'expertise liée aux départs du personnel expérimenté.
6-Le transfert des connaissances accélère l'intégration et la performance de nouveaux employés.
7-Des pratiques d'hygiène standardisées réduisent les risques d'infections nosocomiales.

## FACTEURS EXTERNES

- La pénurie de main d'œuvre en CHSLD limite la stabilité des équipes et influence la continuité des apprentissages.
- Le taux de roulement élevé du personnel entraîne une perte continue de compétences et complique la consolidation des pratiques en hygiène et salubrité.
- Les contraintes d'horaire et la charge de travail en CHSLD influencent la capacité des employés à suivre la formation continue.
- La maîtrise variable des outils numériques par les employés peut affecter l'accessibilité et l'efficacité de la formation offerte sur un support numérique.
- Les formations obligatoires imposées par le MSSS et la CNESST peut réduire le temps et l'attention disponibles pour la formation en hygiène et salubrité.
- La limite budgétaire déterminée par le CHSLD peut restreindre l'ampleur, la fréquence et les modalités de la formation continue.
- La survenue d'éclosions d'infections peut perturber la mise en œuvre de la formation.
- Les nouvelles directives du MSSS peut influencer le contenue de la formation. Il faut avoir un budget annuel pour la mise à niveau du contenu de la formation.